

ΟΞΕΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Κλινική εικόνα: Τα συμπτώματα εμφανίζουν συνήθως οξεία έναρξη (κλιμακώνονται ενίοτε εντός 10-15 ημερών), υπάρχει η παρουσία τυπικών κλινικών σημείων, ενώ σχεδόν πάντοτε υπάρχει κάποιο στρεσογόνο ερέθισμα που σχετίζεται ή πυροδότησε την οξεία διαταραχή. Ο ασθενής (που μπορεί να πάσχει ήδη από κάποια ψύχωση) συχνά μπορεί να αναφέρει ότι «ακούει φωνές» ή να έχει άλλες ακουστικές ψευδαισθήσεις, να έχει παράξενες πεποιθήσεις ή φόβους, να έχει επίμονες παραληρητικές ιδέες, να εμφανίζει ανακοπές ή παρεμβολές στη ροή της σκέψης, να είναι καχύποπτος ή να παρουσιάζει σύγχυση (**θετικά συμπτώματα**). Μπορεί επίσης να υπάρχουν λιγότερο θορυβώδη συμπτώματα, όπως μειωμένο ή καθόλου ενδιαφέρον για τη ζωή, μηδενισμός, ανηδονία, συναισθηματική απόσυρση, πτωχή ροή και υφή του λόγου, διαταραχή της προσοχής, άκαμπτη σκέψη (**αρνητικά συμπτώματα**).

Διαφορική διάγνωση: Λοιμώδεις ή εμπύρετο νόσημα, υπογλυκαιμία, επιληψία, μεταβολικά αίτια, τοξίκωση ή στέρηση αλκοόλ/ουσιών ή φαρμάκων, υποξία, άνοια, ΚΕΚ, όγκοι ΚΝΣ.

Ιστορικό: Σύντομο και στοχευμένο. Έλεγχος για συννοσηρότητα (προσοχή στην ηπατική και νεφρική λειτουργία του ασθενούς). Ελέγχουμε για ιστορικό προηγούμενων νοσηλειών. Ερευνούμε την πιθανότητα να διέκοψε ο ασθενής την αγωγή που λάμβανε για ένα χρόνιο ψυχιατρικό ή μη νόσημα ή την πιθανότητα υπερδοσολογίας των φαρμάκων για την ψυχική νόσο. Ιδιαίτερη προσοχή, απαιτείται δε, αν πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο του ασθενούς.

Οι οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές (ΨΔ), κατηγοριοποιούνται στις εξής:

- ▶ Οξεία Πολύμορφη ΨΔ, χωρίς συμπτώματα Σχιζοφρένειας (F23.0).
- ▶ Οξεία Πολύμορφη ΨΔ, με συμπτώματα Σχιζοφρένειας (F23.1).
- ▶ Οξεία Σχιζοφρενικόμορφη ΨΔ (F23.2).
- ▶ Άλλες οξείες, κυρίως παραληρητικές ΨΔ (F23.3).
- ▶ Άλλες οξείες και παροδικές ΨΔ (F23.8).



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε - αν είναι εφικτό - τα ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂, T °C) και γλυκόζη.
2. Ο χώρος ασφαλίζεται, απομακρύνουμε αιχμηρά αντικείμενα, έχουμε πάντοτε προσωπικό κοντά μας. Προσπαθούμε να μειώσουμε το stress του ασθενούς, ενώ αποφεύγουμε την αντιπαράθεση ή την άσκηση κριτικής για το συμβάν, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Ασθενείς με «**θετικά συμπτώματα**» ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην φαρμακευτική αγωγή πρώτης γραμμής στο ΤΕΠ. Έτσι χορηγείται:
 - **Αλοπεριδόλη** - φάρμακο εκλογής (1-2 amp. Aloperidin 5 mg, im) } **στην ίδια σύριγγα**
 - **Βιπεριδένη** (1 amp. Akineton 5 mg, im)
 - **Χλωροπρομαζίνη** (1 amp. Zuledin 25 mg, im ή ½ - 1 tab. Solidon 100 mg, po).
3. Σε σοβαρές περιπτώσεις, χορηγούμε ½ - 1 amp. Stedon 10 mg (im), στον άλλο γλουτό.
4. Οι ασθενείς με εντονότερα τα «**αρνητικά συμπτώματα**» φαίνεται ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση Ολανζαπίνης (Zyprexa) ή Κλοζαπίνης (Leronex), ενώ σε περίπτωση κατατονίας μπορεί να βοηθήσει και η χορήγηση Λοραζεπάμης (Tavor), ήτοι:
 - 1 amp. Zyprexa 10 mg (im). Αν χρειαστεί, επανάληψη της δόσης μετά από 2-3 ώρες.
 - 1 amp. Tavor 1 mg (im ή iv) (αν συγχωρηγηθεί με Ολανζαπίνη δίδονται μόνο per os).
5. Ενημερώνουμε τους συγγενείς ή συνοδούς – εάν υπάρχουν – για την παρούσα κλινική κατάσταση του ασθενούς, ενώ επικοινωνούμε με την κοντινότερη ψυχιατρική δομή για λήψη περαιτέρω οδηγιών ή για το ενδεχόμενο πιθανής παραπομπής του ασθενούς. Άμεση παραπομπή σε Ψυχιατρική κλινική, απαιτείται ειδικά για τους ασθενείς με έντονο αυτοκτονικό ιδεασμό, που έχουν ήδη ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να βλάψουν τη ζωή τους, καθώς και για ασθενείς που εμφανίζουν έντονα σημεία και συμπτώματα χρόνιας τοξικότητας λόγω υπερδοσολογίας φαρμάκων ή από την κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών.